Préparer les ateliers pratiques de l’UE B3

Semaine 46 • 9 au 13 novembre 2026 • Référentiel infirmier 2026

Objectif

Se préparer aux ateliers annoncés dans le planning : prévention des infections et hygiène des mains, douleur, confort, ergonomie et mobilisation, enfant sain, paramètres vitaux, orthèses, pansements, fils et agrafes. Ce livret organise les repères déjà présents dans le classeur et le programme de la semaine. Il ne remplace ni le support du formateur, ni le protocole du terrain.

Le même fil conducteur pour chaque soin

1. Préparer	Lire la consigne; vérifier le matériel; sécuriser l’environnement; réaliser l’hygiène des mains; respecter la tenue et les équipements requis.
2. Entrer en relation	Se présenter, vérifier l’identité selon la règle locale, expliquer le soin, rechercher l’accord et les préférences; préserver intimité et pudeur.
3. Évaluer avant d’agir	Douleur, vigilance, capacités, risques de chute, état cutané, fatigue, compréhension et besoin d’aide. Demander l’encadrement si une donnée manque.
4. Réaliser dans son champ	Suivre la démonstration et le protocole; encourager la participation; ne pas improviser un geste, un réglage de dispositif ou un traitement.
5. Réévaluer et transmettre	Vérifier confort, douleur, tolérance, sécurité et résultat; remettre l’environnement en ordre; tracer faits, horaires, actions, réponse et alerte utile.

Repère étudiant

En stage ou en atelier, un étudiant agit sous l’encadrement prévu. En cas de doute, d’inconfort nouveau, d’aggravation ou de consigne non comprise : arrêter en sécurité, prévenir le formateur ou l’IDE référent et demander la conduite à tenir.

1. Prévention des infections et hygiène

Les précautions standard s’appliquent à tout soin et à toute personne. Elles protègent la personne soignée et le professionnel; les précautions complémentaires et protocoles du service s’ajoutent si besoin.

Hygiène des mains et tenue

- Avant et après un contact ou un soin : appliquer les indications d’hygiène des mains enseignées et le protocole local. La friction hydroalcoolique est utilisée si les mains ne sont pas visiblement souillées; suivre la procédure locale pour le lavage.
- Gants : les porter lorsque l’exposition le justifie (sang, liquides biologiques, muqueuses, peau lésée ou risque identifié). Ils ne remplacent jamais l’hygiène des mains; les changer entre tâches et personnes.
- Protection : choisir tablier, surblouse, masque ou protection oculaire selon le risque de projection, l’isolement et la consigne. Retirer sans contaminer les vêtements ou les mains.
- Organisation : séparer propre et sale; préparer le matériel nécessaire; éviter de toucher inutilement les surfaces; éliminer les déchets dans la filière indiquée; nettoyer ou désinfecter le matériel réutilisable selon le protocole.
- Tenue : respecter la tenue professionnelle et les règles du site. Les bijoux aux mains/poignets et les ongles artificiels nuisent aux conditions d’hygiène des mains.

Avant de commencer, vérifier

Identité et accord • indication de l’atelier • allergies ou précautions signalées • matériel adapté et fonctionnel • environnement sûr • hygiène des mains • EPI adaptés au risque • élimination et entretien prévus.

Signaux à faire remonter

Exposition accidentelle, rupture d’asepsie, matériel défectueux, erreur de personne, objet piquant mal éliminé ou incident : sécuriser la situation, prévenir immédiatement selon la procédure et tracer avec le professionnel encadrant. Ne pas masquer l’événement.

Sources de travail dans ton classeur

UE B3 « Prévention du risque infectieux » et « Hygiène, environnement et circuits »; recommandations de précautions standard SF2H. Revoir les indications exactes dans le protocole du lieu de stage.

2. Douleur, confort et communication

Le soin relationnel fait partie du soin technique : informer et écouter permet de mieux adapter le geste, d'obtenir une participation possible et de repérer une difficulté.

Évaluer la douleur de façon reproductible

- Quand la personne peut répondre, recueillir son auto-évaluation avec l'échelle adaptée et ses propres mots. Garder le même outil pour comparer lorsque cela est pertinent.
- Si la communication verbale est altérée, observer le comportement avec l'outil d'hétéro-évaluation retenu par le service; rechercher les habitudes de la personne et demander les informations utiles à l'équipe ou à l'entourage avec son accord.
- Préciser le contexte : repos, mouvement, transfert, soin; localisation, début, durée, intensité, facteurs aggravants ou apaisants et retentissement.
- Comparer avant, pendant et après l'action ou le soin; tracer la valeur, l'outil, les conditions, les mesures réalisées et la réponse observée.
- Une douleur nouvelle, intense, inhabituelle ou persistante malgré les mesures prévues appelle une transmission rapide à l'IDE ou au formateur.

Confort, dignité et participation

- Demander comment la personne préfère être appelée et ce qu'elle peut ou souhaite faire elle-même. Ne pas parler à sa place si elle peut répondre.
- Expliquer une étape à la fois; laisser le temps de comprendre et de répondre; vérifier le confort thermique, la pudeur, l'installation et les effets de l'effort.
- Chez la personne âgée, ne pas attribuer automatiquement une douleur, une confusion ou une baisse d'autonomie à l'âge. Repérer le changement par rapport à l'état habituel et le signaler.
- Pour l'enfant sain, adapter mots, rythme et installation à son âge et à sa compréhension; inclure le parent selon le cadre, l'accord de l'enfant et les règles de l'atelier.

À retenir

Ne pas conclure « pas de douleur » parce que la personne ne se plaint pas. Une modification de comportement peut avoir plusieurs causes : douleur, fatigue, peur, gêne, environnement ou autre problème. Observer, questionner sans suggérer de réponse et transmettre.

Sources de travail : support UE B3 « Douleur : échelles, évaluation et suivi »; HAS, évaluation de la douleur chez les personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale.

3. Ergonomie, mobilisation et paramètres vitaux

Mobiliser en sécurité

- Évaluer avant le transfert : consigne, capacités habituelles, douleur, vigilance, équilibre, fatigue, appareillage, environnement et nombre d’aidants requis.
- Expliquer le mouvement, obtenir la participation possible, dégager le trajet, régler le lit et le fauteuil, freiner les équipements et chausser la personne de manière adaptée.
- Utiliser l’aide technique enseignée et demander de l’aide si la situation dépasse ses capacités. Ne pas tirer sur le bras ou l’épaule, ni réaliser seul un transfert incertain.
- Pendant et après : surveiller douleur, vertige, essoufflement, pâleur, instabilité et tolérance; interrompre si un signe inquiétant apparaît, sécuriser la personne et alerter.
- Ajuster sa propre posture, rapprocher la charge, éviter les torsions et ne pas compenser une mauvaise organisation par un effort physique. L’ergonomie dépend aussi du matériel et du travail collectif.

Mesurer, vérifier, interpréter, alerter, tracer

Avant	Pendant	Après
Choisir le paramètre utile; expliquer; installer; vérifier l’appareil, le brassard/capteur et les conditions de mesure.	Respecter la technique enseignée; observer l’état clinique et la tolérance; ne pas retarder l’alerte si l’état paraît préoccupant.	Comparer aux valeurs antérieures et au contexte; vérifier une valeur surprenante si l’état le permet; transmettre l’évolution et tracer heure, conditions et action.

Une mesure est une donnée, pas une conclusion

Interpréter les paramètres ensemble et selon l’âge, l’état habituel, les symptômes, les traitements et la situation. Aucune valeur isolée ne remplace l’observation clinique ni les seuils d’alerte du service. En tant qu’ESI, signaler au professionnel encadrant et appliquer les consignes de l’établissement.

Référence de travail : UE B3 « Paramètres vitaux et biologiques » du classeur.

4. Orthèses, pansements, fils et agrafes

Orthèse : vérifier la tolérance, ne pas régler au hasard

- Confirmer la consigne et le côté concerné; expliquer le dispositif; respecter l'installation indiquée et le niveau d'encadrement.
- Avant et après la pose ou le retrait prévu : observer douleur, confort, état cutané accessible, rougeur persistante, frottement, œdème, couleur, chaleur, sensibilité et mobilité distale selon l'atelier.
- Vérifier que le dispositif n'est ni déplacé, ni trop serré, ni détérioré. Ne pas modifier un réglage ou une prescription sans validation; signaler immédiatement douleur croissante, engourdissement, changement de couleur ou gonflement.

Pansement, sutures et agrafes : observer et transmettre

- Avant le soin : vérifier l'identité, l'indication, les allergies, la douleur, le matériel et la consigne; préparer l'environnement et respecter la technique d'asepsie enseignée.
- Décrire la plaie de manière factuelle et comparable : localisation, dimensions si demandées, aspect du lit et des berges, exsudat, état cutané autour, douleur et évolution.
- Réaliser uniquement les étapes enseignées et autorisées dans le cadre de l'atelier; suivre le plan de soin et le protocole. Ne pas choisir seul un pansement, un antiseptique ou un traitement.
- Fils et agrafes : l'atelier peut porter sur le matériel ou la technique. Leur retrait relève d'un cadre défini; ne pas retirer sans validation, compétence, indication et procédure appropriées.
- Après : vérifier la tolérance, l'absence de saignement ou de complication visible, l'élimination du matériel, le confort et la traçabilité.

Mini auto-évaluation avant l'atelier

1	Qu'est-ce que tu vérifies avant un transfert ?
2	Que fais-tu si une mesure surprenante s'accompagne d'un malaise ?
3	Pourquoi les gants ne remplacent-ils pas l'hygiène des mains ?
4	Quelles données factuelles compares-tu pour une plaie ?
5	Que fais-tu si une orthèse provoque engourdissement ou douleur croissante ?

Sources consultées : planning promotion semaine 46; supports UE B3 déjà classés (prévention du risque infectieux, hygiène/environnement/circuits, douleur, paramètres vitaux, plaies/cicatrisation/escarres); SF2H, Précautions standard (2017); HAS, douleur et troubles de communication; HAS, prévention des escarres; HAS, prévention des chutes; INRS, manutention manuelle. En atelier, les consignes locales priment.